Fabio Folgheraiter
(a cura di)

Il servizio sociale postmoderno

Modelli emergenti



Erickson

Il servizio sociale postmoderno
F. Folgheraiter (a cura di)
Erickson

Editing
Annalisa Pasini

Fotocomposizione
Mirko Pau

Copertina
Giordano Pacenza

© 2004 Edizioni Erickson
Loc. Spini, 154
38014 Gardolo – Trento
Tel. 0461 950690
Fax 0461 950698
www.erickson.it
info@erickson.it

Stampa
La Grafica – Mori (TN)

ISBN: 88-7946-670-4

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo effettuata, se non previa autorizzazione dell'Editore.

Fabio Folgheraiter (a cura di)

Il servizio sociale postmoderno

Modelli emergenti

Erickson

5. La riequilibratura del potere terapeutico: il concetto di empowerment

Concetto tra i più fecondi e «trasversali» delle scienze umane (utilizzato in psicologia, sociologia, pedagogia, scienze politiche, lavoro sociale, ecc.), l'empowerment può essere definito come un processo nel quale le persone o i gruppi svantaggiati/oppressi scoprono ed esercitano appieno la loro capacità di azione, intesa anche come disponibilità e capacità di lotta contro coloro che li opprimono (o contro ciò che li opprime). In tal modo, i soggetti acquisiscono *la sensazione di aver potere* (il «senso di autoefficacia» di cui parla Bandura, 2000) ed anche in realtà essi acquisiscono potere effettivo nel governo della loro vita. Nella tradizione delle politiche sociali e del lavoro sociale, l'empowerment è il processo di riequilibratura e accrescimento del potere personale, interpersonale e politico che i cosiddetti «utenti dei servizi», o le comunità locali nel loro complesso, possono attivamente ricercare, con o senza aiuti esterni, per migliorare la loro situazione di vita (Gutierrez, 1994). Per questo scopo, se necessario, essi arrivano a contrastare attivamente strutture o sistemi che riproducono forme inaccettabili di imposizione di potere o di limitazione o impedimenti strutturali della loro libertà di azione. Tra queste strutture tendenzialmente «dis-empowerizzanti», sempre più spesso gli utenti tendono a vedere anche quei servizi sociali istituzionali e quei professionisti di aiuto che operano secondo il tradizionale modello tecnico-specialistico.

Le radici dell'empowerment si possono ritrovare nei fondamenti politici e filosofici della cultura occidentale, in primo luogo nel concetto di democrazia che informa le nostre istituzioni politiche, basate sul principio di rafforzamento del potere dei cittadini nel partecipare alle decisioni che riguardano il loro benessere. L'empowerment suggerisce tanto la capacità e possibilità del singolo di determinare la propria esistenza individuale, quanto quella di influenzare le istituzioni e la vita comunitaria attraverso un'adeguata partecipazione democratica alle strutture di mediazione quali la scuola, il vicinato, le chiese, le organizzazioni volontarie e le associazioni di impegno civico. L'empowerment comporta tanto un senso psicologico di controllo personale quanto un interesse per l'azione sociale, il potere politico e i diritti formali (Barnes, 2001).

In quanto «prodotto» o «esito», l'empowerment definisce il grado di potere effettivamente acquisito a seguito dell'impegno, o se necessario della lotta, a tale scopo intrapresa. Questo risultato si riferisce, come detto, sia a uno *stato della mente*, come il sentirsi alla fine capaci e competenti o il percepire entro di sé un senso di potere e controllo (Folgheraiter, 1998; 2000), sia a una *ridistribuzione oggettiva del potere* che risulta dalla modificazione delle strutture sociali dominanti.

Nel lavoro sociale, l'empowerment è soprattutto inteso come una metodologia professionale, dove gli operatori «usano» l'empowerment per produrre un incremento di potere generale negli utenti. Questa prospettiva, tuttavia, comporta qualche sottile rischio, di cui va tenuto conto. Dice Parsloe:

> L'empowerment è il termine più sfortunato che sia mai stato introdotto nel vocabolario del lavoro sociale. Tende in effetti a far capire che una persona, l'operatore sociale, possa renderne «potente» un'altra, l'utente. Questa idea però cozza contro il principio fondamentale di una maggiore equità nella distribuzione del potere su cui il nostro concetto si regge. (Parsloe, 1996)

Gli operatori sociali professionali hanno utilizzato il concetto di empowerment dapprima in un senso antioppressivo e radicale, specialmente nell'ambito del *groupwork* e del *community work*. In una fase successiva, quindi, hanno cercato di incorporare l'idea entro la pratica professonale ordinaria. Quest'ultimo sviluppo è in parte legato alla svolta liberistica e consumeristica del *post-welfare state* (Donati e Folgheraiter, 1999; Folgheraiter, 2003), e in parte ai recenti avanzamenti teorici nelle metodologie di aiuto, in particolare alla migliore comprensione del ruolo autonomo e creativo degli utenti, dei carer e dei cittadini interessati nella produzione delle cure sociali (Folgheraiter, 1998), secondo le intuizioni del pensiero relazionale (Donati, 1991). In questa accezione, empowerment significa «trasferimento di potere terapeutico o di cura» ai soggetti altrimenti destinati a essere materia grezza per il potere manipolativo altrui.

L'empowerment come pratica radicale e antioppressiva

Per quanto il servizio sociale come professione abbia sempre, storicamente, mantenuto un atteggiamento apertamente sbilanciato a favore dei poveri o comunque dei soggetti meno tutelati, la prospettiva dalla quale gli operatori hanno guardato verso queste persone e la scelta delle azioni da compiere si sono differenziate nel corso delle epoche, in base ai diversi modelli culturali di riferimento.

Così molti hanno visto gli individui svantaggiati come responsabili della propria situazione e bisognosi di correzione e l'intervento nei loro confronti ha assunto spesso l'immagine della beneficenza, volta soprattutto a correggere l'immoralità e la non accettabilità dal punto di vista sociale. Altri, all'opposto, hanno visto le popolazioni sfavorite come vittime della cattiva organizzazione sociale, dell'ingiustizia sociale e del mutamento sociale. Questi, come riformatori sociali, si sono confrontati con le cause profonde dei problemi, con la modifica delle strutture societarie e si sono impegnati nella promozione di cambiamenti politici e legislativi finalizzati a migliorare le condizioni ambientali e le opportunità disponibili.

Le radici dell'empowerment nel lavoro sociale sono principalmente individuabili in questa seconda categoria e, in modo particolare, nell'azione dei social worker aderenti al movimento dei Settlement, diffusosi negli Stati Uniti negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento. In questo periodo, l'accelerata industrializzazione aveva portato a un'urbanizzazione e a ondate di immigrazione interna ed esterna senza precedenti. In questo frangente, gli operatori sociali dovevano confrontarsi con delle inadeguate strutture sanitarie e abitative, un'assenza di tutela legislativa per i lavoratori (soprattutto dei minori e delle donne) e la difficile integrazione tra le diverse culture. Si dedicarono così a ricerche e interventi che privilegiavano «l'agire insieme» con le persone in situazioni di bisogno, per rafforzare le loro capacità d'azione ed esercitare pressione sui responsabili politico-economici, al fine di migliorare le condizioni di vita garantite alla collettività (Bortoli, 1997).

Tuttavia, almeno fino alla fine degli anni Sessanta, il lavoro sociale professionale ha privilegiato una prospettiva che tendeva a etichettare i destinatari dei suoi interventi, pur nella diversità delle espressioni utilizzate («assistiti», «utenti», «pazienti», ecc.) come persone «incapaci», «dipendenti», «bisognose di soccorso», ecc. Queste etichette sottintendevano che gli operatori avessero le conoscenze, il potere e l'autorità necessaria per «assistere», «guarire» e «trattare», mentre i destinatari delle prestazioni erano individui di fatto «incapaci» che ricevevano passivamente soccorsi, aiuti, terapie e quant'altro.

Questa concezione era strenuamente avversata da una parte minoritaria di operatori, che amavano definirsi «animatori sociali». Costoro interpretavano i cambiamenti strutturali e la giustizia sociale come obiettivi per i quali le persone svantaggiate dal sistema sociale avrebbero dovuto lottare, utilizzando gli strumenti che l'ordinamento giuridico democratico metteva loro a disposizione. Questa posizione, che va dal movimento dei Settlement al movimento Rank and File negli anni Trenta, fino al Radical social work a partire dagli anni Sessanta (Bailey e Brake, 1975), si è riconosciuta via via nei valori di azione comunitaria, di uguaglianza, di equità sociale, alla cui base è ben riconoscibile una chiara idea di empowerment. A differenza del lavoro sociale che si esplicava nelle attività di aiuto individuale *(casework),* questa concezione sovvertitrice dei rapporti di potere dominanti nella società intera difficilmente poteva trovare spazio nel servizio sociale istituzionale, garantito dalle amministrazioni pubbliche; anzi, secondo autorevoli studiosi, se questo fosse avvenuto, sarebbe stato un controsenso (Alinsky, 1971).

Accanto alle convinzioni radicali volte al cambiamento socio-politico, si sono progressivamente affermate tendenze professionali volte al cambiamento socio-culturale, orientate a modificare gli atteggiamenti negativi o svalutanti, presenti anche all'interno degli stessi servizi sociali, nei confronti degli utenti e dei gruppi svantaggiati. Tale azione si rivolge principalmente contro le culture che tendono a opprimere le minoranze etniche, le donne e gli utenti maggiormente a rischio di stigma ed è perciò detta «antioppressiva» (Payne, 1997).

L'empowerment nella concezione liberistica

Nel corso degli anni Ottanta, in Gran Bretagna è stato ripreso il concetto di empowerment in un'accezione alquanto distante da quella radicale-antioppressiva di cui sopra. Essa si riferisce principalmente al processo di decostruzione del potere delle corporazioni professionali e dei servizi statutari del welfare state socioassistenziale, enfatizzando il ruolo del consumatore e del suo potere di scelta all'interno del mercato assistenziale. Nella riforma liberistica del 1990, il «rafforzamento» del consumatore-utente è l'obiettivo primario (assieme al contenimento della spesa) di tutta la politica sociale della cosiddetta Nuova Destra.

Nell'ambito del servizio sociale radicale si è guardato ovviamente con molta diffidenza e anche sarcasmo a questa paradossale concezione dell'empowerment (Langan, 1998). In effetti, l'espressione si era sorprendentemente trasformata da concetto cardine dei movimenti «rivoluzionari» degli anni Sessanta a bandiera della Destra per la liberazione dell'individuo attraverso le libere forze del mercato, le quali avrebbero opposto allo Stato oppressivo la creatività (il potere) della libera iniziativa individuale e d'impresa.

La critica ideologica che viene mossa dagli esponenti del Radical social work alla nozione di empowerment sottesa alle politiche dei governi conservatori è quella di basarsi su di una concezione individualistica del potere che, riducendo le relazioni sociali al livello interpersonale, nasconde le reali relazioni di forza presenti nella società. Ecco allora che il bullismo a scuola o nelle strade sembra rappresentare la principale minaccia pubblica, mentre lo Stato, il luogo dove realmente risiede il potere della società, appare non messo a fuoco. Altra critica è quella di utilizzare l'empowerment e il suo «alone semantico» positivo per nascondere retoricamente una cruda politica di *laisser faire,* giustificando lo smantellamento dello Stato sociale. Affermando giustamente che gli utenti, le famiglie e le comunità hanno «potere» di azione, che non è bene che qualcuno impedisca loro di affrontare i problemi se ne sono capaci, diviene politicamente accettabile agli occhi dell'opinione pubblica ridimensionare l'impegno pubblico per il welfare (Marsland, 1996; Langan, 1998).

Sul piano dei riscontri empirici, dalle ricerche condotte in Gran Bretagna per comprendere i reali effetti della riforma consumeristica risulta che in realtà il coinvolgimento e la partecipazione degli utenti alla programmazione dei servizi socioassistenziali risultano minimi, se non di facciata, così come l'effettiva possibilità di acquisto autonomo di prestazioni assistenziali su un libero mercato. In qualche modo questo esito non risulta del tutto inatteso, poiché nella formulazione della legge di riforma l'empowerment prendeva il secondo posto rispetto al «vero obiettivo» del contenimento della spesa pubblica. Inoltre, il protagonismo degli utenti si è risolto prevalentemente in un'azione di consultazione, non di coinvolgimento reale e di autentica libertà di scelta (Sharkey, 2000). Nella prospettiva neoliberale, la politica dell'empowerment si riduce spesso alla sollecitazione degli utenti e dei loro rappresentanti a partecipare a decisioni tecnico-amministrative rispetto alle quali non hanno, in realtà, serie possibilità di controllo. Così, ad esempio,

la legge prevede che i genitori o i parenti di minori sottoposti a procedimenti di tutela debbano essere «potenziati» attraverso la partecipazione alle cosiddette *case conferences* (Bell, 2001), dove rischiano peraltro di diventare collusi con le misure di intervento statale nella loro vita familiare, decise dai professionisti o dalla polizia. Allo stesso modo, i destinatari di prestazioni socioassistenziali risulterebbero «potenziati» per il fatto che l'assistente sociale case manager che viene loro assegnato è anche il gestore di un budget «decentrato» e autonomo rispetto all'amministrazione. Tale gestione tuttavia, è sempre limitata da rigidi criteri manageriali (Payne, 1998), che spesso mal si collegano con gli specifici bisogni degli utenti/consumatori (Blakemore, 1998).

Altri studiosi britannici, tuttavia, non sono così pessimisti. Pur concordando circa la retorica e le possibili strumentalizzazioni politiche collegate all'empowerment di stampo conservatore, ritengono che i decisi pronunciamenti istituzionali in direzione di un maggior potere degli utenti e dei carer abbiano costituito uno stimolo positivo per la pratica professionale degli operatori sociali. L'enfasi sul potere dei cittadini nei confronti di quello delle amministrazioni pubbliche e dei professonisti può, in effetti, essere uno stimolo affinché le pratiche professionali divengano sempre più aperte e realmente interattive (Sharkey, 2000). È stato anche uno stimolo per risvegliare e legittimare il protagonismo collettivo degli utenti (Blakemore, 1998), di cui diremo brevemente di seguito.

L'empowerment agito autonomamente: i nuovi movimenti sociali degli utenti e dei carer

Specie nel campo della psichiatria e della disabilità fisica, si è assistito negli anni Novanta a un proliferare di organizzazioni di utenti e di familiari del tutto autonome dai servizi formali e dai loro operatori professionisti, se non spesso in aperta contrapposizione. Secondo gli appartenenti a questi movimenti, l'empowerment è una questione che li riguarda in via esclusiva e che non intendono delegare. Essi non si propongono un generico cambiamento sociopolitico, ma si impegnano in un'azione libera da condizionamenti o strumentalizzazioni professionali in direzione dell'adeguamento legislativo, di una migliore definizione dei loro bisogni, di un'affermazione della loro identità rispetto all'opinione o alla cultura dominante, di una più adeguata

azione di fronteggiamento dei problemi loro tipici, basandosi primariamente — fino dove possibile — sulle loro stesse risorse di auto/mutuo aiuto.

I movimenti degli utenti e dei carer rimangono intenzionalmente distinti dai servizi istituzionali e dalle corporazioni professionali, avendo il preciso scopo di affermare la specifica visione dei portatori diretti delle problematiche assistenziali in contrapposizione agli interessi e alle visioni dei tecnici addetti ai lavori. Frequentemente, tuttavia, le organizzazioni di utenti interagiscono con professionisti che dimostrano particolare sensibilità e capacità di collaborazione paritaria, solidali e «alleati» con il movimento (spesso in virtù di una concezione antioppressiva della pratica professionale). Non è necessario che tali operatori professionisti siano a loro volta utenti o carer, cioè direttamente toccati dalle circostanze per le quali il movimento è attivo, ma questa eventualità è in genere apprezzata (Barnes, 2001).

La tendenza a sentirsi separati, se non in contrapposizione con il sistema dell'*expertise* assistenziale, si estende anche al volontariato. Le organizzazioni non profit costituite da persone «abili» o «normali», che volonterosamente si attivano per fornire servizi e prestazioni alle persone «bisognose» della società, sono anch'esse considerate dai disabili come «esterne» e, in ultima analisi, addirittura estranee rispetto ai loro interessi, quasi che anche fare volontariato in qualche misura possa comportare un esercizio di potere arbitrario sulle loro esistenze di «assistiti». Tale senso di difesa dei disabili arriva a estendersi persino nei confronti degli stessi carer informali (anche quando si tratti di familiari stretti), dato che le esigenze degli uni non necessariamente coincidono con quelle degli altri (Heron, 2002).

Le autonome iniziative collettive degli interessati costituiscono ormai un importante fronte d'azione sociale, con caratteristiche distintive tali da prefigurare la necessità di considerarle separate rispetto al tradizionale terzo settore. In questo comparto rimarrebbero comprese le iniziative sociali non profit svolte da chi agisce «per gli altri», mentre nel Quarto settore potrebbero appunto essere comprese le iniziative di quanti agiscono, in forma collettiva, per se stessi.

Interessante rispetto all'empowerment è l'azione di quegli utenti che, per anni, si sono trovati sottoposti a un rigido e invasivo controllo della loro vita da parte delle istituzioni assistenziali e dei professionisti dell'aiuto. Il caso estremo è quello degli ex internati in ospedali psichiatrici o in istituzioni

asilari «totali», persone che, ritrovandosi ancora abbastanza «integre», hanno beneficiato di programmi di deistituzionalizzazione e di reinserimento comunitario. Essi si definiscono «sopravvissuti» *(survivors)* rispetto all'azione di quelle strutture che, per perseguire l'obiettivo di prendersi cura di loro o finanche di guarirli, li hanno per così dire confiscati, esercitando un controllo totale su ogni aspetto della loro esistenza. Il rischio, di cui si è via via estesa la consapevolezza, era quello che l'internamento producesse destrutturazioni e danni permanenti nella personalità e nella capacità di azione dei sottoposti a una tale misura. Nonostante ciò, molti sopravvissuti e fuoriusciti da tali rischiose istituzioni si sentono in grado di (sentono di «avere il potere di») agire in forma collettiva, per riequilibrare le posizioni di potere rispetto a chi è ufficialmente abilitato a effettuare diagnosi su di loro e per affermare il diritto a decidere delle loro vite nonostante gli handicap o le malattie che oggettivamente li riguardano. Questi ex pazienti concepiscono l'empowerment come un loro diritto di azione diretta. Essi non respingono solo l'idea che i professionisti della psichiatria classica possano continuare a occuparsi di loro. Più in generale, essi negano con forza che il loro «potenziamento» possa essere la conseguenza intenzionale di una nuova sofisticata tecnica professionale detta appunto empowerment, esercitata «su di loro» ancora una volta come uno strumento di potere a favore di chi lo utilizza.

L'empowerment relazionale: il lavoro sociale di rete

Esiste una concezione intermedia tra l'idea che l'empowerment sia un avanzato e illuminato procedimento tecnologico che, in ultimo, serve a far aumentare l'efficienza e il potere dei professionisti, e l'idea che esso sia un'esclusiva rivendicazione di autonomia e di potere di una parte soltanto, quella che si reputa svantaggiata. È quanto emerge seguendo il filone di pensiero che origina dalla fenomenologia e dalle istanze postmoderne, una prospettiva che vede il processo di aiuto professionale non come l'esatta applicazione di una competenza tecnica esclusiva, bensì come un incerto ma fiducioso iter di «ricerca», condivisa tra tutti i potenziali interessati alla soluzione di un problema. In questa ottica gli utenti, i carer, gli specialisti e tutti i cittadini interessati, per quanto portatori di interessi differenti, sono incoraggiati a uscire in parte dalla rigida polarizzazione dei loro ruoli per

divenire agenti tendenzialmente «alla pari», nella ricerca del benessere cui sono cointeressati (Folgheraiter, 1998; 2000).

Secondo questo modo di interpretare il lavoro sociale, gli utenti divengono di fatto «operatori», cioè vedono aperta davanti a sé la strada per agire nello stesso modo in cui agisce un operatore professionista: sentendosi in grado e «autorizzati» a esprimere creatività e responsabilità per la ricerca di soluzioni. La metodologia di rete prevede, quanto all'empowerment, che i detentori ufficiali del potere terapeutico cedano parte di questo potere alle persone che tradizionalmente stavano ad attendere passive le soluzioni «certe» da loro pensate. In questo senso si può dire che «l'utente non c'è» (Folgheraiter, 2000) essendo egli concepito come un «agente» capace (e comunque non impedito dall'esercizio altrui) di intraprendere quel tipico genere di azioni (esprimere i propri punti di vista, ponderare le cose, prendere decisioni, valutare l'efficacia delle azioni intraprese, ecc.) che sono da sempre considerate appannaggio di chi è abile a risolvere i problemi.

L'esperto cede potere, cioè lascia fare agli interessati quanto è in loro potere fare, anzi incentiva il loro fare e il loro decidere predisponendo condizioni favorenti e assicurando l'opportuna supervisione, permettendo così agli interessati di concorrere alla pianificazione profonda del loro aiuto o della rivendicazione dei loro diritti. Gli specialisti a loro volta traggono da questa aumentata «produttività sociale» rinnovato potere e impensate opportunità di apprendimento. L'idea è che l'operatore non abbia il mandato di potenziare le persone, ma che le persone siano agenti sensati, per quanto deboli e svantaggiate appaiano agli occhi di chi si trova in posizioni «superiori». Da parte dei professionisti, va soprattutto evitato il rischio di smantellare involontariamente questo intrinseco potere d'azione attraverso concezioni paternalistiche e assistenzialistiche, sulla base della subdola idea che i problemi sociali abbiano soluzioni oggettive e «migliori» e che queste vadano comunque imposte, in omaggio a un presunto dovere di impiantare nel mondo la «felice perfezione» della razionalità oggettiva.

L'empowerment inteso come «trasferimento di potere» da ruoli istituzionali e professionali al mondo della vita non è, in questa prospettiva, un gioco a somma zero (Barnes e Bowl, 2003). L'ottica relazionale invita a riflettere sul fatto che se il professionista cede potere ai suoi interlocutori ne riceve in cambio di nuovo, in quantità e qualità non esistente prima dell'interazione. Quando il potere è scambiato e intrecciato, piuttosto che semplicemente «ceduto», esso si ri-genera e si moltiplica.

Cedere potere è un cedimento di professionalità, o piuttosto viceversa?

Le argomentazioni sviluppate sin qui possono essere approfondite alla luce della teoria sociologica della professionalizzazione. Guardando bene tra le righe di quanto detto, al professionista esperto potrebbe apparire chiara la possibilità di elevare il livello della propria professionalità. Nella cornice dell'approccio relazionale postmoderno, egli andrebbe a differenziare le proprie funzioni e, accanto al suo tradizionale ruolo terapeutico se lo vuole mantenere, entro i limiti sopraddetti, potrebbe assumere un ruolo strategico di più elevato tenore. Egli diventa *guida professionale delle iniziative terapeutiche altrui*. Lungi quindi dal sentirsi sminuito nel suo potere tecnico dal protagonismo (potere) di altri, anche non professionisti, nel suo stesso campo di intervento, l'operatore specialista dovrebbe essere stimolatore/supervisore di questi poteri «esterni» affinché il tutto si traduca in un maggiore potere comune (comunitario) e anche senz'altro in una maggiore efficacia dell'istituzione per cui lavora (che a sua volta, essendo istituzione di welfare, si traduce in benessere generale della società). L'attività di supervisione intenzionale dell'*agency* societaria finalizzata al welfare è una competenza o meglio una capacità esclusiva, tipicamente professionale, in quanto solo un professionista sofisticato riesce a sostenerla con piena intenzionalità.

Si potrebbe qualificare come «super-professionista» quell'operatore che è appunto così avanzato da riuscire a ritagliarsi un ruolo di ordinatore e osservatore di molteplici iniziative, sia di carattere esperto che esperienziale, che si sviluppano entro il suo raggio d'azione, iniziative che non hanno bisogno di lui materialmente per realizzarsi ma che forse senza la sua stimolazione non si sarebbero messe in moto e senza la sua continua osservazione a supporto non saprebbero mantenersi nel tempo riproducendosi, o non riuscirebbero ad assicurare una qualità accettabile. È risaputo che le energie comunitarie di carattere informale possono prendere «coraggio» e sentirsi tonificate dalla presenza, dietro le loro spalle, di una risorsa professionale di questo livello, cognitivamente orientata all'empowerment. Come detto, tale risorsa deve stare in equilibrio su un filo sottile. Deve essere attenta a non soffocare le possibili azioni consorelle agendo *al posto loro*, con il pretesto di far meglio, oppure semplicemente perché non si rende neppure conto che tali risorse «altre» esistono, o potrebbero esistere. Al contrario, neppure deve lasciarle in balia di carichi pesanti e ingestibili, senza un'adeguata

riflessione di fronteggiamento. Il «super professionista» postmoderno deve fare lasciando fare, o lasciar fare facendo, il che è obiettivamente complicato, ma forse meno di quanto sembri. In ogni caso questo suo posizionamento intelligente — un passo indietro per stimolarne molti più di quanti potrebbe farne lui direttamente — solo con una valutazione superficiale può essere scambiato per una perdita di potere e di prestigio professionale: in realtà l'operatore guadagna in autorevolezza ed efficacia, più di quanto è possibile immaginare in astratto, finché non si prova davvero a cimentarsi.

Per poter svolgere il ruolo di guida di relazioni autonome che concorrono al suo stesso obiettivo, l'operatore deve disporsi con un animo aperto e sereno, deve essere consapevole della sua forza e della forza (differente dalla sua, ma anch'essa importante) delle altre persone che incontra nel lavoro. Dovrebbe assumere nel relazionarsi un atteggiamento di «potenziamento dell'altro», identificato come importante dagli utenti recuperati che guardano indietro e vedono le competenze professionali che più li hanno aiutati nel loro recupero, o che più avrebbero desiderato incontrare (Ribner e Knei-Paz, 2002).

In sintesi

Questi sono i principi a cui devono riferirsi gli operatori sociali professionali che vogliono adottare l'orientamento dell'empowerment in una concezione che non sia né paternalistica né delegante, ma pienamente relazionale:

1. L'empowerment è un processo collaborativo nel quale utenti, carer e cittadini da un lato e operatori dall'altro trovano facilitazioni nel lavorare assieme come partner.
2. Il processo di empowerment vede gli utenti come soggetti potenzialmente competenti e capaci di decidere che cosa è bene per la loro vita.
3. Gli utenti sono considerati in grado di autopercepirsi come agenti di cambiamenti significativi nella loro vita, così come anche nelle interazioni «tecniche» con gli operatori professionali, là dove si costruiscono le «terapie».
4. La competenza viene acquisita o affinata attraverso un'azione corroborata dalle esperienze di vita. Gli operatori d'empowerment quindi non sostituiscono l'azione degli interessati per sfiducia preconcetta, ma la «aspettano», la sostengono, eventualmente dando feedback per orientarla.

5. Dall'empowerment dei propri interlocutori (cioè dal rafforzamento del loro senso di avere potere) gli operatori traggono opportunità di apprendimento e aiuti per l'esercizio delle competenze «esperte», e così di seguito circolarmente.
6. L'azione degli interessati alla soluzione dei problemi che li riguardano può estendersi oltre la sfera delle loro circostanze «private» e dipanarsi collettivamente per modificare il sistema politico o socioculturale dominante. Anche in questi casi, gli operatori professionisti possono assecondare i processi in atto, fin dove il loro ruolo istituzionale e le loro convinzioni di cittadini lo consentono.

Bibliografia

Alinsky S. (1971), *Rules for radicals*, New York, Vintage Books.

Bailey R. e Brake M. (a cura di) (1975), *Radical social work*, London, Edward Arnold.

Bandura A. (2000), *Autoefficacia. Teoria e applicazioni,* Trento, Erickson.

Barnes M. (1999), *Utenti, carer e cittadinanza attiva. Politiche sociali oltre il welfare state,* Trento, Erickson.

Barnes M. (2001), *Utenti come cittadini: nuovo forme di governance del welfare locale,* «Lavoro Sociale», vol. 1, n. 3, pp. 365-382.

Barnes M. e Bowl R. (2003), *Empowerment e salute mentale,* Trento, Erickson.

Bartlett H. (1971), *The common base of social work practice,* New York, NASW.

Bell M. (2001), *Il coinvolgimento della famiglia negli interventi per minori a rischio,* «Lavoro Sociale», vol. 1, n. 2, pp. 167-187.

Blakemore K. (1998), *Social policy: An introduction*, Buckingham, Open University Press.

Bauman Z. (1996), *Le sfide dell'etica,* Milano, Feltrinelli.

Beck U. (2000), *La società del rischio: verso una seconda modernità,* Roma, Carocci.

Bortoli B. (1997), *Teoria e storia del servizio sociale,* Roma, Carocci.

Bortoli B. (2003), *Che cos'è il case management?,* in F. Folgheraiter (a cura di), *La liberalizzazione dei servizi sociali,* Trento, Erickson.

Bortoli B. (2004), *Biografie. Mary Richmond: la fondatrice del servizio sociale professionale,* «Lavoro Sociale», vol. 4, n. 2, pp. 265-278.

Bortoli B. (2004a), *Biografie. Jane Addams: tra impegno sociale e impegno politico fino al Nobel per la pace,* «Lavoro Sociale», vol. 4, n. 1, pp. 123-132.

Bury, M. (1998), *Postmodernity and health*, in Srambler, G. and Higgs, P., *Modernity, medicine and health*, London, Routledge.

Colaianni L. (2004), *La competenza ad agire: agency, capabilities e servizio sociale,* Milano, Angeli.

Davies R.(a cura di) (1998), *Stress in social work,* London, Jessica Kinsley.

Donati P. (1991), *Teoria relazionale della società,* Milano, Angeli.

Donati P. (1996), *Sociologia del Terzo settore,* Roma, NIS.

Donati P. (1998), *Lezioni di sociologia*, Padova, Cedam.

Donati P. e Folgheraiter F (a cura di) (1999), *Gli operatori sociali nel welfare mix: Privatizzazione, pluralizzazione dei soggetti erogatori, managerialismo,* Trento, Erickson.

Ferguson H. (2002), *Lavoro sociale e politiche della vita,* «Lavoro sociale», vol. 2, n. 3, pp. 303-321 (in questo volume).

Ferrari E. (a cura di) (2000), *I servizi a rete in Europa. Concorrenza tra gli erogatori e garanzia dei cittadini,* Milano, Cortina.

Fletcher K. (2000), *La negoziazione nei servizi sociali e sanitari,* Trento, Erickson.

Folgheraiter F. (1994), *Interventi direte e comunità locali,* Trento, Erickson.

Folgheraiter F. (1998), *Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva direte,* Milano, Angeli.

Folgheraiter F. (1998b), *L'approccio relazionale in educazione e terapia: tre studi di caso*, «Difficoltà di apprendimento», vol. 4, n. 1, pp. 95-113.

Folgheraiter F. (2000), *L'utente che non c'è. Lavoro direte ed empowerment nei servizi alla persona,* Trento, Erickson.

Folgheraiter F. (a cura di) (2003), *La liberalizzazione dei servizi sociali,* Trento, Erickson.

Gallino L. (1993), *Dizionario di sociologia*, Torino, Utet.

Giddens A. (1991), *Modernity and self-identity*, Cambridge, Polity.

Giddens A. (1994), *Le conseguenze della modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo,* Bologna, Il Mulino.

Gutierrez L.M. (1994), *Beyond coping: An empowerment perspective on stressful life events*, «Journal of Sociology and Social Welfare», n. 21, pp. 201-219.

Haley J. (1977), *Le strategie della psicoterapia,* Sansoni, Firenze.

Heron (2002), *Aiutare i carer*, Trento, Erickson.

Johnson L.C. e Yanca S.J. (2001), *Social work practice: A generalist approach,* Boston, Allyn and Bacon.

Kelly H.H. (1979), *Personal relationship: Their structure and process,* Hillsdale, LEA Publ.

Kropotkin P. (1914), *Mutual aid,* Boston, Extending Horizon Books.

Langan M. (1998), *Radical social work.* In R. Adams, L. Dominelli e M. Payne (a cura di), *Social work. Themes, issues and critical debates*, London, Macmillan.